

Consultório

O manual de quem atende: ver o seu dia, chamar o paciente, escrever a sessão, prescrever, assinar e acompanhar a evolução de cada pessoa.

PARA QUEM É ESTE MANUAL

Médicos, fisioterapeutas, acupunturistas e a equipe de enfermagem.
É o programa instalado na máquina da sala de atendimento.

NESTE MANUAL

Meu dia e minha semana

Escrever a sessão

Prescrever e assinar

Infusão e enfermagem

Dor, medidas e escalas

Programa: **Clínica SemDor — Consultório** (ícone azul com o nome “Consultório” na área de trabalho).

Explica cada tela, cada botão e o caminho de um atendimento do começo ao fim.

O que você vai encontrar aqui

1	Antes de começar	abrir, entrar e entender a tela
2	O caminho de um atendimento	do “Atender” ao “Finalizar”
3	Minha agenda	Hoje · Semana · Sessões sem evolução
4	A tela do paciente	as sete seções e o que tem em cada uma
5	Escrever a sessão	a folha única, a EVA e o mapa corporal
6	Detalhar a sessão em campos	anamnese, exame físico, hipótese, plano, retorno
7	Prescrições e documentos	receita, atestado, comparecimento, pedido de exame
8	Assinatura digital	quando é obrigatória e como funciona
9	Prescrição de infusão	a folha que a enfermagem executa
10	Enfermagem	sala de infusão e passagem de enfermagem
11	Acompanhamento	dor, medidas e escalas clínicas
12	Exames e anexos	pedir, receber o laudo e guardar
13	Meus números	o seu desempenho, só seu
14	Quando algo dá errado	as mensagens do sistema
15	Perguntas frequentes	
16	Glossário	

Antes de começar

Abrir o programa, entrar com o seu usuário e reconhecer as partes da tela. Depois disto, todas as telas ficam parecidas.

COMO LER ESTE MANUAL

As figuras **ainda não são fotos do sistema** — são reproduções feitas a partir do próprio código, e cada uma sai marcada com um selo laranja avisando disso. Elas são fiéis no que importa: os nomes dos botões, das colunas e dos campos são **exatamente** os que você vai ver no computador, e as cores também. Assim que as capturas reais forem tiradas, elas entram no lugar e o selo some.

1.1 · Abrir e entrar

Dê dois cliques no ícone **Consultório** na área de trabalho. O sistema pede **usuário** e **senha**. Esse login é o que assina tudo o que você escrever: a evolução, a prescrição, a assinatura do documento. **Nunca trabalhe no login de outra pessoa.**

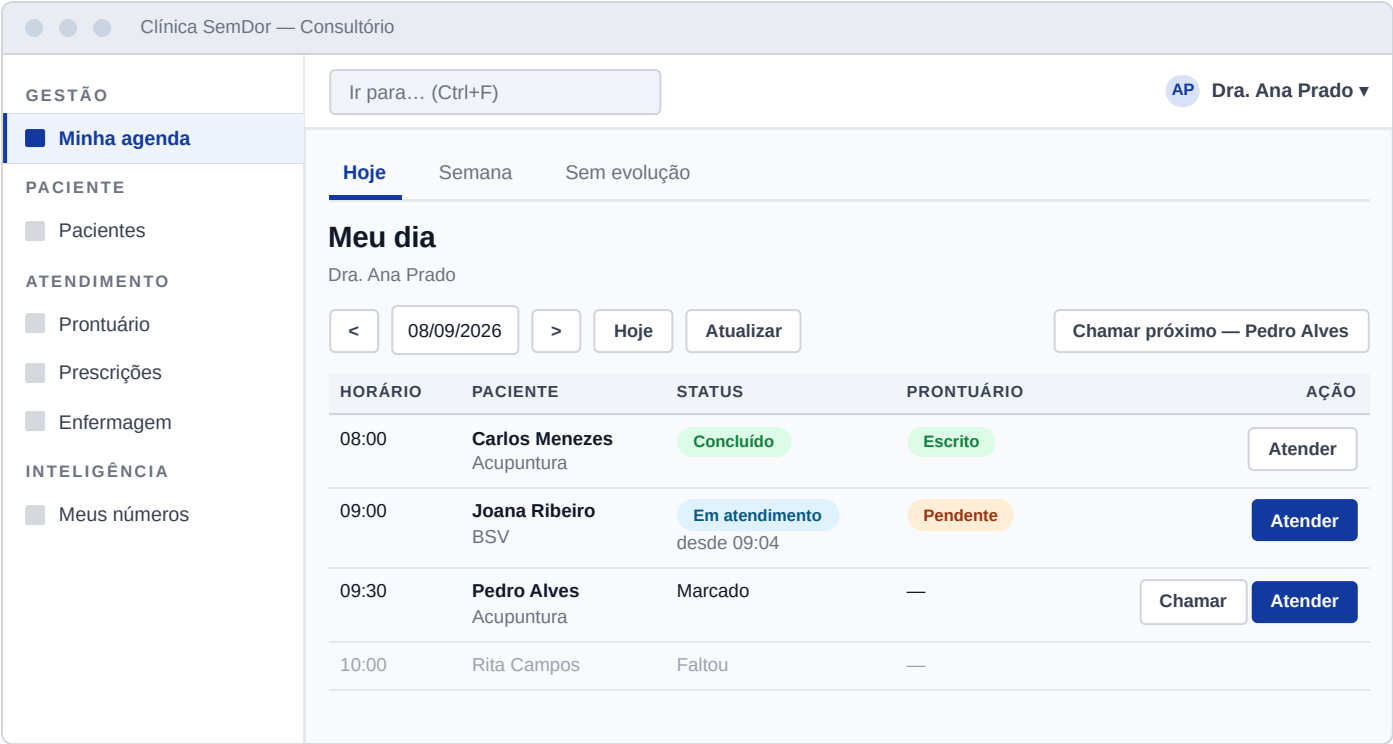
- **Primeiro acesso:** a direção entrega uma senha provisória e o sistema pede uma nova.
- **Trocar a senha:** clique no seu nome (canto superior direito) > **Trocar a senha**.
- **Trocar de pessoa no mesmo computador:** **Trocar usuário**. O programa reabre pedindo login.

SEU USUÁRIO PRECISA ESTAR LIGADO AO SEU CADASTRO DE PROFISSIONAL

É essa ligação que faz o sistema saber que a agenda é a sua, copiar o seu **CRM/COREN** em cada registro e conferir o **CPF do seu certificado digital** na hora de assinar. Sem ela, o sistema mostra o dia da clínica inteira e **avisa na tela** que está fazendo isso. Peça à direção para fazer a ligação uma vez, em **Acessos**.

1.2 · A tela por dentro

ILUSTRAÇÃO — não é uma captura da tela real



A tela “Meu dia”. Uma linha por horário, com o estado do paciente e se a evolução daquela sessão já foi escrita. **Atender** é o botão do dia: abre o prontuário e registra a entrada na sala. O “Chamar” ao lado é opcional.

- 1 **Menu (esquerda)** — separado por assunto. Clicar no nome do grupo abre e fecha o grupo.
- 2 **Busca de telas (Ctrl+F)** — digite “exame”, “infusão”, “receita” e ele mostra onde fica.
- 3 **Seu nome** — trocar a senha e trocar de usuário.
- 4 **Abas** — quando um item responde mais de uma pergunta, elas aparecem embaixo do título.

1.3 · Cinco coisas que valem em todas as telas

VOCÊ VÊ	QUER DIZER
Botão apagado	Falta alguma coisa: escolher o paciente, preencher um campo, ou você não tem aquela permissão.
Traço “—”	Não medido , que é diferente de zero. Um mês sem sessão não tem “queda média da dor”.
Faixa vermelha	Erro ou recusa, com o motivo escrito ao lado do botão que você clicou.
“Não foi possível verificar”	A leitura falhou. Não é “está tudo em dia” . Use Atualizar .

VOCÊ VÊ	QUER DIZER
Alerta vermelho no cabeçalho do paciente	Alergia registrada, termo por assinar ou intercorrência recente. Leia antes de prescrever.

O caminho de um atendimento

Três cliques, todos na sua tela: **Atender**, escrever, **Finalizar**. A secretária marca o horário — o resto é com você, e o balcão não precisa fazer nada no meio.

1 · Atender

No **Meu dia**, na linha do paciente. Abre o prontuário dele e registra que ele entrou na sala.

2 · Escrever

A folha da sessão: queixa, EVA, conduta — e o que mais você quiser detalhar.

3 · Finalizar

Encerra a sessão, avisa o balcão que a sala vagou e **gera as guias do convênio**.

UM CLIQUE REGISTRA OS TRÊS CARIMBOS

Ao clicar em **Atender**, o sistema marca de uma vez que o paciente chegou, foi chamado e entrou na sala. Você não precisa que a recepção tenha clicado em nada antes — e ela não precisa clicar em nada depois.

E O “CHAMAR”?

É **opcional**. Serve quando você quer avisar a recepção para chamar o paciente pelo nome na sala de espera antes de recebê-lo. Se você mesmo chama à porta, vá direto ao **Atender**.

O QUE “FINALIZAR ATENDIMENTO” FAZ, EXATAMENTE

Três coisas, nesta ordem: **grava a sessão**, **carimba a hora do fim** (é isso que faz a recepção saber que a sala vagou) e **cria o atendimento com as guias do convênio**. Se a gravação falhar, ele não segue — não faz sentido avisar que você terminou se o que você escreveu não está salvo.

FINALIZAR NÃO É O MESMO QUE “FECHAR O CAIXA”

O dinheiro, o pacote e o material continuam sendo do balcão. Depois que você finaliza, a linha daquele paciente aparece na recepção com um botão de **Fechar sessão** — e ele só aparece quando há algo a resolver: pacote a descontar, material gasto ou paciente particular. Convênio sem pacote e sem material acaba no seu **Finalizar**.

FINALIZAR NÃO TEM VOLTA PELO SEU LADO

Depois de finalizar, o botão de reabrir some: desfazer passa a ser **estorno**, e estorno é ato do balcão, com motivo escrito. Antes de finalizar, confira o que escreveu.

Minha agenda

Um item com três abas, porque são três perguntas diferentes: **o que acontece hoje**, **quando eu tenho espaço** e **o que eu ainda não escrevi**.

Menu **GESTÃO** › **Minha agenda**

3.1 · Aba **Hoje** (Meu dia)

A lista do seu dia, uma linha por horário. Cada linha diz em que pé está o paciente e se a evolução daquela sessão já foi escrita. **O botão que importa é o “Atender”** — os outros são atalhos de quem quer avisar a recepção antes de receber o paciente.

COLUNA / BOTÃO	O QUE MOSTRA OU FAZ
Status	No caminho normal são três: Marcado → Em atendimento (quando você clica em Atender) → Concluído (quando finaliza). No local e Chamado só aparecem se a recepção usar os botões de espera. Cancelados e faltas ficam na lista, em cinza — para você saber que o horário vagou.
Prontuário	Escrito ou Pendente : se aquela sessão já tem evolução.
Atender	O botão do dia . Abre a tela do paciente e registra, de uma vez, que ele chegou, foi chamado e entrou na sala. É por onde o atendimento começa.
Chamar próximo opcional	Avisa a recepção para chamar pelo nome o primeiro da fila que já fez check-in. Só faz sentido se a clínica usa os botões de espera do balcão.
Chamar (na linha) opcional	O mesmo, para um paciente específico.
Desfazer chamada	Cancela a chamada. Chamar de novo não zera o cronômetro: quem insiste precisa continuar vendo há quanto tempo chamou.
Voltar	Desfaz uma etapa (se você marcou entrada por engano).
< > Hoje	Navegam entre os dias. Em outro dia os botões de movimento somem — a fila só corre hoje.

A LISTA SE ATUALIZA SOZINHA

A cada minuto, e em silêncio — sem piscar nem apagar o que está na tela. É assim que a chegada registrada no balcão aparece aqui sem você fazer nada.

3.2 · Aba **Semana**

Sete colunas, de segunda a domingo, no mesmo desenho da grade da recepção. Responde a pergunta que o paciente faz com você ainda na sala: “**quando eu volto?**”

- Dia sem horário aparece **vazio**, e não sumido — semana com cinco colunas faria procurar a quarta-feira que faltou.
- Cancelado e falta aparecem **marcados**, para você saber que aquele vão está livre de novo.
- Férias e feriados aparecem escritos na célula.
- Aqui você **não marca** horário: quem marca é a recepção. A semana é informação.

3.3 · Aba **Sem evolução**

A sua fila de trabalho: **sessões que aconteceram e ainda não têm registro escrito**. É o item que mais protege a clínica — sessão sem evolução é prontuário incompleto e, se a guia já foi faturada, é cobrança sem o documento que a sustenta.

- 1 A lista mostra só **dias anteriores**: a sessão das 14h não é cobrada às 14h05, porque o paciente ainda está na sala.
- 2 Filtre por paciente ou profissional, se quiser.
- 3 Clique em **Escrever evolução** — abre a tela do paciente já naquela sessão.

A tela do paciente

Escolhido o paciente, tudo acontece numa tela só. O nome dele fica no alto o tempo todo, e a coluna estreita da esquerda troca de **seção** sem trocar de paciente.

ILUSTRAÇÃO — não é uma captura da tela real

Clínica SemDor — Consultório

SESSÃO

Atendimento

Enfermagem

PACIENTE

Paciente

Histórico

Exames

Prescrições

Acompanh.

PA

Pedro Alves

Alergia: dipirona

Trocar paciente

54 anos · Petrobras · carteirinha 9912-4 · em tratamento desde 03/2025 · 18 sessões

A sessão de hoje

Sessões anteriores

Enfermagem e infusões

Última sessão 01/09 · EVA 7 → 4 · retorno sugerido em 7 dias · PA 130/80, FC 72 aferidos hoje às 09:12 por Joana (COREN-SP 999999)

DATA DA SESSÃO

EVA ANTES

EVA DEPOIS

08/09/2026

7

3

A SESSÃO DE HOJE

Refere melhora da lombalgia após a última sessão. Mantém rigidez matinal...

Detalhar em campos separados...

3 campos preenchidos

Última gravação às 09:41

Mapa corporal

Modelos...

Emitir documento

Imprimir a sessão

Salvar

Finalizar atendimento

A tela do paciente. Em cima, quem é ele e o que é preciso saber antes de qualquer coisa (alergia, convênio, tempo de tratamento). À esquerda, as seções. No meio, a folha da sessão.

4.1 · As sete seções

SEÇÃO	PARA QUE SERVE
Atendimento	A folha da sessão de hoje — onde se escreve. É onde você passa a maior parte do tempo.
Atendimento de enfermagem	A passagem de enfermagem de hoje. Aparece para quem tem acesso de enfermagem.
Paciente	Duas abas: Ficha e problemas (dados, convênio, lista de problemas e alergias) e Anamnese .
Histórico	Tudo o que já foi escrito: sessões, passagens de enfermagem, com busca dentro do texto.
Exames e anexos	Pedidos de exame, laudos recebidos e arquivos anexados.

SEÇÃO	PARA QUE SERVE
Prescrições e documentos	Receita, atestado, comparecimento, pedido de exame — emitir, assinar e reimprimir.
Acompanhamento	Três abas: Evolução da dor , Medidas e Avaliações (as escalas).

4.2 · O cabeçalho do paciente

Fica visível enquanto o prontuário estiver aberto, e traz de propósito só o que muda conduta:

- **Alergias** — em vermelho, ao lado do nome. Aparecem **mesmo quando dadas por resolvidas**: “resolvida” numa alergia costuma significar “não reagiu da última vez”.
- **Idade, convênio e carteirinha**.
- **Desde quando ele se trata aqui e quantas sessões** já aconteceram de verdade.
- **As últimas hipóteses diagnósticas** registradas (no máximo três, sem repetir).

Trocar paciente volta para a busca. **Iniciar atendimento** aparece quando você chegou até aqui por outro caminho (pela tela da Enfermagem, por exemplo) e ainda não marcou a entrada na sala.

Escrever a sessão

A folha da sessão foi desenhada para o caso mais comum: **escrever em texto livre, durante o atendimento**. O resto — anamnese, exame físico, hipótese, plano — fica a um clique, para quando fizer falta.

Tela do paciente › seção **Atendimento** › aba **A sessão de hoje**

5.1 · Passo a passo

- 1
- Confira a data da sessão. Ela vem do horário que você abriu — e não de “hoje”. Se você está escrevendo agora a sessão de ontem, ela fica com a data de ontem, que é a correta.
- 2
- EVA antes. A dor no começo da sessão, de 0 a 10.
- 3
- Escreva a sessão no campo grande de texto.
- 4
- EVA depois, ao terminar. O sistema lembra: a EVA vale em par — é a diferença entre as duas que desenha a curva do tratamento e vai para o relatório do convênio.
- 5
- Retorno sugerido (opcional): a data em que ele deve voltar. Isso **não marca horário** — faz o paciente aparecer na fila **“Retornos a marcar”** da recepção, que liga para ele.
- 6
- Salvar quantas vezes quiser durante o atendimento.
- 7
- Finalizar atendimento ao terminar.

5.2 · As ferramentas da folha

BOTÃO	O QUE FAZ
Mapa corporal	Abre a figura do corpo para marcar os pontos da sessão. Veja abaixo.
Modelos...	Roteiros de sessão prontos. Repetir a última sessão deste paciente traz o que ele fez da última vez.
Emitir documento	Abre a janela de receita, atestado, comparecimento ou pedido de exame, já no nome dele.
Imprimir a sessão	Gera a ficha do atendimento em PDF para o paciente levar, com o que foi registrado hoje.

BOTÃO	O QUE FAZ
Detalhar em campos separados...	Abre a janela com os campos clínicos. O selo ao lado diz quantos já estão preenchidos .
Colher termo... / Colher assinatura...	Colhe a assinatura do paciente num termo, quando o procedimento exige.

“ÚLTIMA GRAVAÇÃO ÀS 09:41”

O rodapé da folha diz quando você gravou pela última vez. O sistema **não salva sozinho**: cada gravação de uma sessão já existente cria uma versão no prontuário, e salvar a cada pausa encheria o registro de dezenas de versões por sessão. Salve quando quiser — mas salve.

5.3 · O mapa corporal

- 1 Clique em **Mapa corporal**.
- 2 Clique na figura onde a agulha entrou. Cada clique vira um ponto numerado.
- 3 Informe a **técnica** e, se quiser, o **nome do ponto**.
- 4 **Repetir a anterior** traz os pontos da última sessão; **Aplicar** traz os de um protocolo da clínica; **Limpar** apaga tudo.
- 5 **Guardar como protocolo** salva a marcação atual como um roteiro reutilizável. Marque “**Vale para toda a clínica**” se ele deve ficar disponível para os colegas.
- 6 **Concluir** traz os pontos para a sessão. **Eles só são gravados quando você salva a sessão**.

APLICAR UM PROTOCOLO COPIA OS PONTOS

Ele não “aponta” para o protocolo. É isso que faz corrigir um protocolo hoje **não** reescrever a sessão da semana passada — o prontuário tem que continuar dizendo o que foi feito naquele dia.

5.4 · O que a sessão anterior mostra

Ao lado da folha, a aba **Sessões anteriores** traz as cinco últimas, com os campos separados por rótulo. E logo acima da folha há uma linha de contexto que você lê sem clicar em nada: **data da última sessão, o par da EVA e o retorno que foi sugerido** — que é a resposta para “por que este paciente está aqui hoje”.

A aba **Enfermagem e infusões** mostra o que a equipe de enfermagem registrou: sinais vitais, passagens e execução das infusões.

Detalhar a sessão em campos

Clicando em “**Detalhar em campos separados...**” abre uma janela com os campos clínicos. Nada aqui é obrigatório — mas o que for preenchido vira coluna própria no prontuário, sai separado no relatório do convênio e pode ser comparado entre sessões.

CAMPO	O QUE SE ESCRIVE
Queixa principal	O motivo da consulta, nas palavras do paciente.
História da doença atual	Como o problema começou e evoluiu até hoje.
Exame físico	O que você encontrou ao examinar.
Hipótese diagnóstica	O que você pensa que é. Aparece no cabeçalho do paciente nas próximas sessões.
CID (opcional)	O código da classificação. Há um botão Buscar CID... : digite o código ou uma palavra (“lombar”, “ansiedade”) e escolha da lista. O campo aceita qualquer texto — a lista é um atalho, não uma trava.
Conduta	O que foi feito: pontos, técnica, tempo.
Orientações ao paciente	O que ele leva de instrução para casa.
Plano terapêutico	O plano das próximas sessões.
Por que voltar	A razão do retorno sugerido.
Encaminhamento	Para onde o paciente está sendo encaminhado.
Campos personalizados	Campos que a sua clínica criou (“nº de agulhas”, “aparelho”, “carga”). Aparecem só nas modalidades em que fazem sentido.

A JANELA NÃO GRAVA SOZINHA

Ela edita a mesma sessão que está atrás. Quem grava é o **Salvar** da folha. Por isso a janela não tem “Salvar” próprio — teria duas gravações para o mesmo texto.

6.1 · Corrigir uma sessão já escrita

Abra a sessão em **Histórico** (ou pela lista de sessões) e clique em **Editar**.

REGISTRO CLÍNICO NÃO SE APAGA — ELE SE CORRIGE E SE CANCELA

Ao salvar uma correção, o sistema **guarda a versão anterior**. O motivo da correção é opcional; o do **cancelamento** é obrigatório, e o registro cancelado **continua na base**, marcado, com o nome de quem cancelou. É o que permite provar, anos depois, o que estava escrito e quando.

Prescrições e documentos

Quatro folhas saem daqui: **receita, atestado, declaração de comparecimento e pedido de exame**. Cada uma é um documento numerado, que fica guardado na ficha do paciente e pode ser reimpresso igual.

Menu **ATENDIMENTO** > **Prescrições** > **Receitas e documentos** — ou, dentro do paciente, a seção **Prescrições e documentos**

7.1 · Emitir

- 1 Com o paciente escolhido, clique no tipo de folha: **Receita, Atestado, Comparecimento** ou **Pedido de exame**. A decisão vem antes do clique — ninguém pensa “vou emitir um documento”, pensa “vou dar um atestado”.
- 2 Confira **quem assina** (o profissional) e a **data**.
- 3 Escreva o **texto do documento**. Nas receitas, use **Adicionar linha** para cada medicamento.
- 4 Campos próprios de cada folha: o atestado pede **dias de afastamento** e **a partir de**; a declaração de comparecimento pede **chegou às / saiu às**.
- 5 Se quiser reaproveitar depois, **Guardar como modelo**. **Aplicar** traz um modelo salvo.
- 6 **Emitir e imprimir**.

O SISTEMA CONFERE AS ALERGIAS DO PACIENTE NA RECEITA

Ao emitir, ele compara o que você prescreveu com as alergias registradas na ficha e **avisa**, pedindo que você marque “**Eu vi o alerta e assumo esta prescrição**”. Ele avisa e não impede — o registro pode estar errado, pode haver dessensibilização, e quem decide é quem assina. O que ele não deixa é isso acontecer sem ninguém perceber.

Isto não é um checador de interação medicamentosa. Ele compara com o que a própria clínica anotou sobre aquele paciente — nada além disso.

O CID NO ATESTADO SÓ SAI COM AUTORIZAÇÃO

Existe uma caixinha “**O paciente autorizou imprimir o CID no atestado**”. Sem ela marcada, o CID não vai para o papel que o paciente leva ao trabalho.

RECEITA PRECISA DO ENDEREÇO DO PACIENTE

A lei exige o **endereço residencial** e o **modo de usar** para a farmácia poder aviar a receita. Se a ficha estiver sem endereço, o sistema avisa na emissão — e **recusa assinar** digitalmente, porque uma receita assinada que a farmácia não pode aviar é pior do que uma sem assinatura.

7.2 · Os botões da lista

BOTÃO	O QUE FAZ
2ª via	Reimprime o mesmo arquivo que o paciente levou. Não é gerado de novo — a segunda via precisa sair idêntica à primeira.
Assinar	Assinatura digital ICP-Brasil. Veja o capítulo 8 .
Enviar	Manda o documento assinado ao paciente.
Cancelar	Cancela o documento com motivo . Ele continua na lista, marcado como cancelado — e, se estava publicado na internet para a farmácia conferir, sai do ar no mesmo ato.

Assinatura digital

O sistema assina documentos com **certificado ICP-Brasil** — o mesmo e-CPF que você usa para outras coisas. Assinar é o que dá valor jurídico ao **arquivo**.

8.1 · Quando é obrigatório

DOCUMENTO	REGRA
Atestado em arquivo	Só vale assinado digitalmente. Um atestado em PDF sem assinatura não é um documento com defeito — é um arquivo sem valor.
Atestado em papel	Assinado à caneta, sempre valeu. Por isso o aviso some quando a folha vai ser assinada à mão.
Receita, pedido de exame, declaração	A lei aceita assinatura avançada ou qualificada. O sistema usa a qualificada mesmo assim, porque é a que a farmácia confere sozinha num validador público.
Folha de infusão	É documento interno da clínica; a lei dispensa. A clínica pode escolher assinar mesmo assim.

8.2 · Como assinar

- 1 Na lista de documentos, escolha a folha e clique em **Assinar**.
- 2 Escolha o certificado: o do **token/cartão** espetado no computador, ou **Buscar no SafeID (nuvem)**, se a clínica usa certificado em nuvem.
- 3 Autorize no aplicativo do certificado, se ele pedir.
- 4 O sistema **salva o arquivo assinado e o abre** — ele não manda para a impressora. A assinatura vive nos **bytes do arquivo**, não na tinta: imprimir um documento assinado gera uma cópia.

O SISTEMA CONFERE SE O CERTIFICADO É SEU

Ele lê o **CPF de dentro do certificado** e compara com o CPF do seu cadastro. Certificado de outra pessoa, vencido ou sem CPF é **recusado** — senão o e-CPF de qualquer um assinaria a prescrição de qualquer outro.

COMO A FARMÁCIA CONFERE

O documento assinado sai com um **QR code** e um bloco “PARA O FARMACÊUTICO” explicando o passo a passo: abrir a câmera do celular no QR, ou levar o arquivo ao validador de documentos de saúde do governo. Sem essa explicação impressa, muita farmácia recusa por precaução — e tem razão.

UMA COISA QUE ESTE SISTEMA NÃO FAZ DE PROPÓSITO

Ele **não** cola uma imagem escaneada da sua assinatura no PDF. Imagem não prova autoria — quem tiver acesso ao arquivo copia para outro documento. Parecer assinado sem estar é pior do que não assinar.

Prescrição de infusão

A folha que a **enfermagem executa**. Ela não é uma receita: fica dentro da clínica, tem vários itens e tem ciclo de vida — rascunho, assinada, em execução, encerrada.

Menu **ATENDIMENTO** › **Prescrições** › **Infusão**

- 1
- Escolha o paciente e clique em **Nova prescrição**.
- 2
- Monte os itens: medicamento, dose, via, horário. Cada item vira uma linha que a técnica vai checar.
- 3
- Marque “**se necessário**” nos itens que só devem ser administrados sob condição — assim eles não ficam contando como pendência para sempre na sala.
- 4
- Salvar rascunho** enquanto estiver montando.
- 5
- Assinar** quando estiver pronta. É a assinatura que libera a folha para a sala.
- 6
- Imprimir** — a folha sai com as colunas de checagem **em branco** (“Feito às”, “Visto”) e três linhas para o motivo do não realizado. É a via que a enfermeira assina à caneta.

BOTÃO	O QUE FAZ
Editar	Muda a folha. Só enquanto ela não foi assinada, e só nos itens ainda não checados.
Abrir	Mostra a folha por inteiro.
Execução	Abre a folha de execução — o que a enfermagem está marcando.
Cancelar	Cancela a folha, com motivo.

O SISTEMA RECUSA ASSINAR UMA FOLHA COM ALERGIA CONHECIDA

Se algum item bate com uma alergia registrada do paciente, a assinatura é **recusada** até você confirmar por escrito. Assinar sela o arquivo: corrigir depois exige cancelar e emitir outra.

ITEM JÁ CHECADO NÃO SE EDITA NEM SE SUSPENDE

Senão a folha passaria a desdizer uma execução já assinada. Para tirar um item ainda não administrado, use **Suspender** na folha de execução — é ato de quem prescreve.

Enfermagem

Duas telas, duas perguntas: a **Sala de infusão** responde “o que executar agora”; **Passagens** responde “quem eu atendi e o que eu escrevi”.

Menu **ATENDIMENTO** › **Enfermagem** › abas **Sala de infusão** e **Passagens**

10.1 · Sala de infusão

- 1 Ache a folha do paciente na fila — ou **Abrir pelo código**, digitando o código impresso no papel que está na sua mão.
- 2 **Abrir folha.**
- 3 Para cada item administrado: informe a **hora da administração** e clique em ✓ **Realizado**.
- 4 Item não administrado: ○ **Não realizado** — o sistema **exige o motivo por escrito**.
- 5 **Encerrar execução** quando terminar; **Assinar execução** se a clínica pedir a assinatura digital da enfermagem.

BOTÃO	O QUE FAZ
Retificar	Corrige uma checagem. Não apaga : cria linha nova apontando a anterior, com motivo. A folha impressa mostra as duas.
Suspender	Tira um item da folha. É ato de quem prescreve.
Anotar	Observação na folha.
Imprimir folha / registro	A folha é a prescrição; o registro é o espelho do que foi executado.
Mostrar encerradas	Traz de volta à lista as folhas já encerradas.

TRÊS REGRAS QUE O SISTEMA NÃO DEIXA PASSAR

1. A hora é a da **administração**, informada por você — o relógio do computador é gravado ao lado, e a diferença entre os dois é o que uma auditoria procura.
2. **Hora futura é recusada.**
3. Se o item bate com uma **alergia** registrada, o sistema avisa no momento de marcar como realizado e pede confirmação escrita.

10.2 · Passagem de enfermagem

- 1 Escolha o paciente (pela fila do dia ou buscando) e clique em **Atender**.
- 2 **Hora do fato e sinais vitais** — preencha só o que aferiu. A pressão vai num campo só: **120/80**.
- 3 Escreva em **O que eu observei**.
- 4 Marque **Foi uma intercorrência** quando for o caso — acende alerta para o médico por 48 horas.
- 5 Se for **consulta de enfermagem** completa, marque a caixinha e clique em **Abrir a consulta de enfermagem...**: a janela tem as cinco etapas da COFEN 358/2009 em abas — **1 Histórico** · **2 e 3 Diagnósticos** · **4 Cuidados** · **5 Avaliação**.
- 6 **Registrar**.

SINAIS VITAIS AQUI, CURVA NO ACOMPANHAMENTO

A passagem registra o **ponto no tempo** — três aferições na mesma infusão, cada uma com sua hora. A **curva** (pressão ao longo dos meses) fica na seção Acompanhamento > Medidas, e ela lê estas aferições automaticamente, dizendo em cada ponto de onde ele veio.

REGISTRAR ALERGIA: SÓ O AGENTE

No campo de alergia, escreva **o agente** (“dipirona”), nunca a reação (“pressão caiu”). O agente é o que vai alertar a clínica inteira na próxima prescrição. A reação você descreve no texto da passagem, marcando “Foi uma intercorrência”.

O PLANO DE CUIDADOS

Os cuidados prescritos na consulta de enfermagem viram uma lista “**Plano de cuidados de hoje**”, com **Feito** e **Não feito** em cada linha. “Não feito” pede o motivo. Cuidado marcado como “se necessário” não fica cobrando registro.

Acompanhamento

A seção que responde “**como está indo o tratamento**”, em três abas.

11.1 · Evolução da dor

A curva da EVA ao longo das sessões, com **duas linhas**: a dor **antes** e **depois** de cada sessão. Só a de depois diria que o paciente melhorou; só a de antes esconderia o efeito da sessão. O eixo vai sempre de **0 a 10**, que é a escala publicada — ajustá-lo aos dados faria uma queda de 8 para 7 parecer um despençar.

Exportar CSV gera planilha para o Excel.

11.2 · Medidas

Peso, altura, circunferência de cintura, pressão arterial, glicemia, HbA1c. Cada colheita é um fato datado, com a interpretação publicada ao lado (faixa de IMC, por exemplo).

- 1 Clique em **Registrar medida**.
 - 2 Escolha o tipo e informe o valor. A unidade e as faixas vêm do catálogo — você não digita.
 - 3 Confirme.
- **O IMC não se digita**: ele é calculado do peso com a altura vigente, e o sistema mostra **de quando é a altura** usada.
 - **Valor impossível é recusado** (2500 kg é dedo no teclado). Valor **anormal e possível** (210 kg) passa — recusá-lo esconderia justamente quem precisa de atenção.
 - **Meia pressão não existe**: sistólica sem diastólica é recusada, e diastólica maior que a sistólica também (campo trocado).
 - Sem faixa publicada para aquele valor isolado, o selo de interpretação **some** — ausência de faixa não é “normal”.
 - **Cancelar...** pede motivo; a colheita não é apagada.

11.3 · Avaliações (escalas)

As escalas clínicas publicadas, aplicadas dentro do sistema: **EVA, PHQ-9, GAD-7, Oswestry, Katz e FINDRISC**.

- 1 Clique em **Aplicar** e escolha a escala. Marque **Todas as escalas** para ver as que não são da sua especialidade.

- 2 Responda item por item. **Item em branco é recusado** — em branco viraria zero na soma, e zero quer dizer “não tenho esse sintoma”.
- 3 Ao terminar, o sistema calcula o escore e mostra a **faixa** publicada daquela escala.

O SISTEMA PONTUA; ELE NÃO DIAGNOSTICA

A faixa é a leitura publicada da escala, e a tela diz isso o tempo todo. Alguns itens têm alerta próprio: no PHQ-9, o item 9 acende um aviso **mesmo com escore total baixo** — ele vale 3 dos 27 pontos e desapareceria dentro da média.

O gráfico da evolução do escore aparece embaixo, e a aplicação entra no **relatório de evolução** que o paciente leva ao convênio, com a faixa **como foi gravada na época** — e não recalculada pela definição de hoje.

Exames e anexos

Fecha o ciclo do exame: você pede, o laudo volta e fica guardado no prontuário — em vez de ficar num WhatsApp que a clínica não controla.

12.1 · Dentro do paciente

Tela do paciente › seção **Exames e anexos**

BOTÃO	O QUE FAZ
Registrar resultado...	Registra o resultado de um exame. Há um campo “ responde ao pedido ”: escolha o pedido de exame correspondente e o sistema dá baixa na espera.
Anexar laudo...	Anexa o PDF ou a imagem do laudo ao resultado.
Anexar arquivo à ficha...	Guarda um arquivo que não é de sessão nenhuma (uma receita antiga, um documento).
Abrir laudo / Abrir	Abre o arquivo.
Salvar...	Salva uma cópia do arquivo no computador.
Cancelar...	Cancela o registro, com motivo. Não apaga.

VÍDEO E ARQUIVO GRANDE

Arquivo grande (um vídeo de marcha, por exemplo) é guardado no armazenamento da clínica, e não no banco — mas continua sendo registro do prontuário, com guarda e trilha de acesso. Se a gravação do arquivo falhar, o sistema **não cria** o anexo: linha prometendo um vídeo que ninguém tem seria pior.

12.2 · A tela Exames (a fila da clínica)

Menu **ATENDIMENTO** › **Prontuário** › **Exames**

Lista os pedidos de exame com a situação de cada um: **Aguardando resultado** ou **Resultado disponível**. É a resposta para “eu pedi a ressonância; ela chegou?”.

- **Anexar laudo** — quando o exame chega.
- **Ver resultados** — abre o que já foi registrado.
- **Detalhes** — mostra o pedido original.

A situação é **derivada dos fatos**: um pedido só sai de “aguardando” quando existe um resultado amarrado a ele. Não há um campo para marcar “já chegou”.

Meus números

O seu desempenho — **só o seu**. Esta tela não compara colegas: ranking é decisão de gestão, e no aplicativo de cada um viraria placar.

Menu INTELIGÊNCIA › Meus números

NÚMERO	O QUE ELE DIZ
Atendidos	Quantas sessões você concluiu no período.
Faltas e no-show	Quantos pacientes seus não vieram, e o percentual.
Horas	Quanto tempo de agenda você teve ocupado.
Completude do prontuário	Quantas das suas sessões têm evolução escrita. Sem sessão atendida ele mostra “—”, e não 0% — quem tirou férias não é acusado de nada.
Queda média da dor	A diferença média entre a EVA antes e depois das suas sessões.
Ver e escrever	Leva direto para a fila de sessões sem evolução.

A DÍVIDA DE PRONTUÁRIO É DE HOJE, NÃO DO PERÍODO

Ela é fila de trabalho: se ela seguisse o filtro de período, escolher “mês passado” esconderia o que está em aberto agora.

Quando algo dá errado

O QUE APARECE	O QUE FAZER
“Seu acesso não permite...”	Aquela ação é de outro cargo. Fale com a direção — ela libera a função específica para você.
A tela mostra o dia da clínica inteira	Seu usuário não está ligado ao seu cadastro de profissional. O sistema avisa na tela que está fazendo isso. Peça a ligação à direção.
“Não foi possível verificar”	A leitura falhou. Não é “nada pendente” . Clique em Atualizar .
O certificado não aparece na lista	Confira se o token está espetado e se o aplicativo do certificado está aberto. Depois, Atualizar lista .
“Certificado de outra pessoa”	O CPF de dentro do certificado não bate com o do seu cadastro. Ou o certificado é de outra pessoa, ou o CPF do seu cadastro está errado — a direção corrige em Profissionais .
Recusa ao assinar receita	Falta o endereço do paciente, ou há alergia batendo com o que foi prescrito. A mensagem diz qual dos dois.
Um erro em inglês	Falha técnica. Anote a hora e o que estava fazendo, e avise a direção. O detalhe fica em <i>erros-ano-mês.txt</i> , na pasta “logs” ao lado do programa.
Cliquei em Salvar e nada apareceu	Role até o botão — a mensagem aparece perto dele. Não clique várias vezes.

Perguntas frequentes

Preciso esperar a recepção marcar a chegada do paciente?

Não. Clique em **Atender** direto na linha dele — o sistema registra chegada, chamada e entrada de uma vez. A recepção não precisa ter feito nada antes.

E depois que eu finalizo, sobra alguma coisa para o balcão?

Só o dinheiro, e só quando existe: pacote a descontar, material gasto ou paciente particular. A **guia do convênio já nasceu** no seu Finalizar.

Esqueci de escrever a evolução de ontem. Onde acho?

Minha agenda › Sem evolução. A lista traz todas as sessões que aconteceram e não têm registro, de todos os dias anteriores. Clique em **Escrever evolução**.

Atendi o paciente de um colega. Consigo escrever?

Sim. Na clínica todos atendem todos: a lista de **Pacientes** alcança o cadastro inteiro e a busca chega em quem nunca foi atendido. O que fica marcado é **quem escreveu** e **quem atendeu**.

Cliquei em Finalizar sem querer. Como desfazer?

Pelo seu lado não dá — desfazer virou **estorno**, que é ato do balcão, com motivo escrito. Peça à recepção: **Lançar e marcar › Lançamentos › Estornar...**

Escrevi a sessão no paciente errado.

Abra a sessão errada, clique em **Cancelar...** e escreva o motivo (ela fica registrada como cancelada, não some). Depois escreva de novo no paciente certo.

O paciente quer o registro da sessão de hoje.

Na folha da sessão, **Imprimir a sessão**. Sai a ficha do atendimento em PDF, com a marca da clínica. Para o relatório completo do tratamento (o que vai ao convênio), use **Relatório de evolução** na ficha do paciente.

Por que a EVA pede dois números?

Porque é a diferença entre eles que mostra o efeito da sessão. Só o “depois” diria que o paciente melhorou; só o “antes” esconderia o que a sessão fez.

Marquei o retorno sugerido. Isso agenda o paciente?

Não. Ele entra na fila **Retornos a marcar** da recepção, que liga e marca. Quem marca horário é o balcão — o retorno sugerido é uma afirmação clínica sua, não um horário.

Como vejo o que a enfermagem registrou hoje?

Na tela do paciente, aba **Enfermagem e infusões**. Os sinais vitais aferidos hoje também aparecem na linha de contexto, logo acima da folha da sessão, com a hora e quem aferiu.

Um número apareceu como “—”.

Quer dizer **não medido**, e não zero. Sem base de cálculo o sistema nunca inventa um número.

Dá para usar o mesmo texto em várias sessões?

Sim: **Modelos...** guarda roteiros de sessão, e **Repetir a última sessão deste paciente** traz o que ele fez da última vez. Os dois **copiam** o texto para a sessão de hoje — corrigir o modelo amanhã não reescreve o prontuário de ontem.

Glossário

Evolução	O registro escrito da sessão. Não se apaga: corrige-se (guardando a versão anterior) ou cancela-se com motivo.
EVA	Escala visual analógica de dor, de 0 a 10. Registrada antes e depois de cada sessão.
Anamnese	A primeira conversa clínica: histórico, hábitos, antecedentes. Escrita uma vez por pessoa.
Hipótese diagnóstica	O que se pensou naquela sessão . Diferente da lista de problemas, que é o que o paciente tem.
Lista de problemas	Os diagnósticos e alergias ativos do paciente. Alergia alerta mesmo dada por resolvida.
Mapa corporal	A figura onde se marcam os pontos da sessão. Some com a sessão — é a mesma coisa vista de outro jeito.
Protocolo	Um conjunto de pontos salvo para reutilizar. Aplicar cópia os pontos.
Modelo de evolução	Um roteiro de texto salvo para reutilizar na sessão.
Escala	Instrumento publicado (PHQ-9, GAD-7, Oswestry, Katz, FINDRISC) que transforma respostas em escore e faixa.
Guia	O documento com que a clínica cobra o convênio. Nasce quando o atendimento entra no sistema.
Finalizar atendimento	Encerra a sessão, avisa o balcão que a sala vagou e gera as guias.
Prescrição de infusão	A folha interna que a enfermagem executa item a item.
Checagem	Afirmar que um item foi (ou não foi) administrado, com hora. Não se apaga: retifica-se.
Passagem de enfermagem	O registro do que a enfermagem observou, com hora e sinais vitais.
Consulta de enfermagem	O processo em cinco etapas da COFEN 358/2009, ato privativo do enfermeiro.
ICP-Brasil	O padrão brasileiro de certificado digital. É o que dá valor jurídico ao documento em arquivo.

Termo	O papel que o paciente lê e assina antes de um procedimento.
Prontuário	Tudo o que é clínico daquele paciente. A lei manda guardar por 20 anos.

Este manual descreve o aplicativo Consultório da Clínica SemDor. Os nomes de botões, colunas e campos foram tirados do próprio sistema. Se a sua tela tiver mais (ou menos) itens de menu, é o seu acesso — quem concede é a direção, na tela de Acessos.